جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : منى السيد احمد مخيمر

المحافظة : القليوبيه **الحي / المدينة :** كفر شكر **العنوان :** اسنيت مركز كفر شكر-القليوبيه

رقم البطاقة : 28109290102062 **رقم التليفون :** 01016543142 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 29-09-1981 **المهنة :** حاصل علي دبلوم

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**

التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للرقبة والصدر والبطن والحوض بالصبغة [11128] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: منى السيد احمد مخيمر
National ID: 28109290102062

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

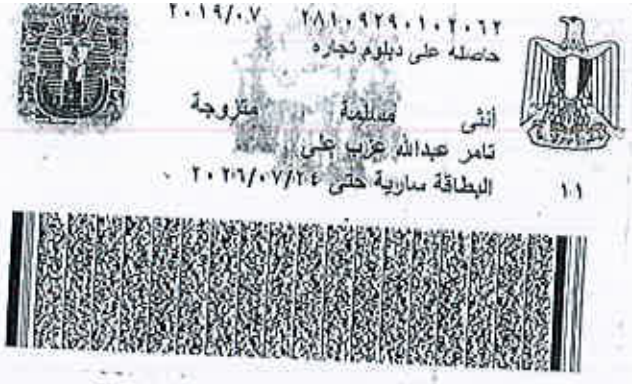
تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of neck, chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





DMS
مقطعة
مسح زري

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

06/01/2026

MDT FORM

Name:	Fatma Abdelsalam Gouda Hassanen	MRN:	3166
Age:	57 Y	ID:	26902172200763
Menopausal Status:	post	Phone:	01005766814
NRS SCORE:		Marital Status:	
BMI:		Family History:	
CO Morbidity:	-VE	Reason Of MDT:	post op

Clinical Data:

BX: RIGHT IDC G2

ER 8 PR 7 HER 3 KI67 50

R L



TNM

Sonomammography:

Mets Workup:

History:

Initially ct2 n1Right breast cancer (Post-NACT), Right breast wide local excision, Sentinel lymph nodes biopsy & Extra-lymph nodes: - No residual viable remnants of the previously diagnosed invasive tumor. ? Ductal carcinoma in situ: Absent. ? Surgical margins: Free. + Total nodal status: Eight free lymph nodes (0/8). - Histologic response to therapy:

Recommendations:

for adj ttt

MDT Outcome & Plan

PORT
CONTINUE ADJUVANT PHESGO
ADJUVANT AI

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Name: منى السيد احمد مخيمر **MR. :** 4444	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

METASTATIC BREAST TO BONE TRIPLE NEGATIVE ON TAXOL BS AND CTS 0N 9/2025 SD FOR W25 TAXOL

comparative CT SD of osseous lesion pending approval of taxol + zometa, for continuation of ttt

for week 26 taxol with supportive for peripheral neuropathy an gastric support pending qarar for zometa

for w26 taxol 120 mg add controloc methyltechno and ondalenz w27 28 pharmacy

prem mbc to bone triple -ve history rt mrm on 2019 t3 n2 mo rec 4 ac 12 taxol .6/2023 bone metsa rt si j left femur st taxol weekly from 8/2023 cts 9/2025 sd of osseous lesions bs 9/2025 sd rec till 12/2026 26 cycles of 3 weeks weekly taxol and 1 week res cts 2/2026 sd of oss lesions for continuation for new cts bs for mdt for further plan of tt as pt has grade 2-3 pn for taxol 120 mg

Mdt >>PATIENT COUNSELING REGARDING STOP TAXOL FOR A WHILE AND START XELODA after pt counseling pt want to continue on taxol new Cts , bone scan , MRI brain >>> pending today for taxol 120 mg , zometa 4 mg after labs , next 2 weeks taxol >> pharamcy

Pharmacy Note For W30 Taxol 120 Ionized ca : 1.01 Postpone zometa

today for zometa and taxol w31, labs done last week next week phamacy taxol 32 and 33 (w33 with labs)

Zometa Will be taken Next week After new cal level

cts on 20/6/2026 small left adrenal nodule only l1 vertebral sclerotic nodule likely bone island bone scan ; single equivocal lesion in sternum fort ct corr (no abnormality in cts) significant RD of osteoblastic activity of [elvic and left femoral lesion for w32 taxol and zometya w33 ,34 ph

FOR WEEK 35 TAXOL PN GI, tolerated so far last CTs show regressive course, MDT 5/2026 > for xeloda which pt attempted to use but couldnt tolerate, so she returned to taxol w36 taxol pharmacy

For W37 taxol labs accepted week 38 and week 39 pharmacy labs accepted

cc grade 1 pn ,fatigue for 10% dr for w40 taxol 110 mg w41 ph and methyltechno

تحريرا في ,

التاريخ :	**19-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : **dina makram**

يعتمد ,

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECHON SUPPORT

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

جهه الاصدار :فرع القليوبية

تاريخ الاصدار :2024-1-15

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعون لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمراة المعيله .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التامينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) منى السيد احمد مغيمر بطاقة رقم 28109290102062

وطبقا الى خطاب من التامينات الإجتماعية برفد عدم الأنتفاع

يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى يصدر هذا الخطاب دون اى مسئولية على الهيئة العامة للتامين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التامين الصحى الشامل

وشكرا

المعاون المختص
خالد السيد

تاريخ الطباعه :2024-1-15

إدارة مركز نظم المعلومات

مسلسل 1223939

الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية او وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

Non-HIO Letter
[[DOCTYPE:NON_HIO_LETTER]]

ة المراكز الطبية المتخصصة
كز أورام دار السلام
ره المعمل
سم الباثولوجى

Pathology Report

Name: منى السيد احمد Age: 38 years.

Clinical data: Right breast cancer.

Specimen type: Right MRM

Date: 20/8/2019

Lab. Number: 714 **Hospital Number: 2913/2019**

Gross Description:

MRM breast tissue; 22x17x7 cm, skin ellipse; 22x15 cm including nipple and areola. It showed an ill-defined firm greyish white mass; 7x6 cm and another capsulated lobulated greyish white mass; 6.6x6 cm, located 1cm apart. Rest of breast showed wide nodular greyish pink tissue. The least margin (deep) was 1.5 cm. axillary tissue measured; 12x9 cm entangling 20 nodules, largest is 2.5x2.5 cm.

Microscopic Examination:

histopathological examination of sections prepared from the tumour mass reveals poorly fixed infiltrating malignant epithelial growth made up of small groups and thin cords of pleomorphic hyperchromatic malignant lobular epithelial cells. Admixed with groups and sheets of pleomorphic hyperchromatic malignant ductal epithelial cells. Stromal desmoplasia is moderate. Cellular and nuclear atypia are moderate [grade II]. Surrounding breast tissue showed autolyzed fibroadenoma and multiple foci of DCIS . Positive lymphovascular emboli. Positive perineural invasion.

Nipple showed scattered ghosts of tumor cells with free epidermis. The surgical margins are free. 9 out of the 22 lymph nodes detected show metastatic deposits.

Diagnosis:

Right breast cancer, MRM;

Poorly fixed. Mixed ductal and lobular carcinoma GII.

Surrounding breast showed multiple foci of DCIS and autolyzed fibroadenoma.

Nipple: scattered ghosts of tumour cell with free epidermis

Positive lymphovascular emboli.

Positive perineural invasion.

Free margin.

Lymph node 9/22.

Stage: T3N2.

Prof. Dr. Lubna Qmar

Prof. Dr. Essam Ayad

Dr. Marwa Mahmoud

Generated Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form:

ent ID:
ame : منى السيد احمد مخمر Sex: Female 3- Medical number: 63152355 Old Med : Old Med : 2913/2019

umber: 29109290102062 Patient Age : 42 Y

y history	Family History 4-VE	Plano	Phone 01026543142	BMI	BMI	REASON OF MDT	REASON OF MDT ADHOT
al status	Marital Status MARRIED	NRS Score	NRS Score	GROUP	GROUP H	Date of MDT	Date Of MDT 28/02/2024
orbidity	Co Morbidity DM	Menopausal status	Menopausal Status PREMENOPAUSAL	Initial STAGE	Initial STAGE		

Clinical data

st Imaging :

Mets Workup :

	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	KI67
HENT)	0/8 IR COMMENT)	0/8 PR COMMENT)	0 Her 2 Neu Comments)	SISH COMMENT)	

	N	M
		BONE?

mammography
M BIRADS I

ENT HISTORY
MRM PT3 N2 M0-->ADJ ACX4-->TAXOL 12WK LAST ONE ON 2020
CAP 6/23-->WELL DEFINED SCLEROTIC LYTIC OSSEOUS LESIONS
NE SCAN-->6/2023-->2 RT SACRO ILIAC REGION AND TROCHANTERIC REGION OF LT FEMUR
STLY METS
0-1,NO PAIN,NO TENDERNESS
E NO MASSES,,SHE IS ON FOLLOW UP SINCE 2020
FURTHER TTT

MDT OUTCOME & PLAN

COME & PLAN
pan CTs , US & BONE SCAN...
t TAXOL WEEKLY & ZOMETA EVERY 3 MS.

SIGNATURE

XCAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY	RADIOLOGY	RADIOLOGY
GERY	SURGERY	PATHOLOGY	PATHOLOGY
hiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Total DLP (mGy.cm) |:

Patient Name: Mona Al Sayed Ahmed Mekhemer	Date : 14/05/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 42 Year(s)
Medical ID: 2913/2019	Pat. ID: 42840

- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Skeletal survey shows:
  - Bilateral inferior and left superior pubic rami and left symphysis pubis multiple frcatutres with callus formation.
  - Left 5th-10th ribs frcatutre with callus formations some show malalignment.
  - L1 vertebral body, left proximal femoral shaft and left ischial bone sclerotic bone lesions and right iliac mixed mainly sclerotic bone lesion.

Opinion:

- **No CT evidence of pulmonary or hepatic metastatic deposits, on non contrast study.**
- **Bilateral inferior and left superior pubic rami and left symphysis pubis multiple frcatutres, left 5th-10th ribs frcatutres.**
- **L1 vertebral body, left proximal femoral shaft and left ischial bone sclerotic bone lesions and right iliac mixed mainly sclerotic bone lesion, could be metastatic for bone scan correlation.**

Dr.Nancy Gamal
Dr. Reham Anwar, FEBR, MD

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL CANCER CAMPUS

Patient No.	:2913-2019		
Patient Name	:الأستاذه / منى السيد احمد مخيمر	Request No	:13004626
Sex	:Female Age:43 Y	Request Date	:07-10-2025 13:31
Financial Cate	:جوستاف روسي - نفقة الدولة	Verification Date	:07-10-2025 13:56
Department	:Out Patient	Sample Type	:Serum
Referring Doc	:	Test Status	:Routine
		Analyzers	:Gem3000_1_Hermel

Clinical Chemistry Report

Test	Result	Unit	Ref. Range
Calcium Ionized (Ca++)	0.97	mmol/l	1.10 - 1.30)

Signature

Dr./Radwa Younes

فاكس / 25311121 ت/ 25311125 - 25311128
987 كورنيش النيل الملك الصالح

Lab Test
[[DOCTYPE:LAB_TEST]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
إدارة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
إدارة الأشعة

Total DLP (mGy.cm) | :

Patient Name: Mona Al Sayed Ahmed Mekhemer	Date : 14/05/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 42 Year(s)
Medical ID: 2913/2019	Pat. ID: 42840

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Right MRM is noted
- Right upper lobar subpleural reticulations likely postradiotherapy changes.
- Clear the rest both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes (apart from bilateral renal cortical cysts)
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

ا.د. أحمد كمال الدرى
ا.د. محمد أبو الهدى درويش
ا.د. عمر حسين عمر
ا.د. وحيد حسين طنطاوى
أساتذه الأشعة التشخيصية
كلية الطب – جامعة عين شمس

مركز مصر للأشعة
MISR RADIOLOGY CENTER MRC

Mrs.Mona Al Sayed Ahmed Mekhemer Patient ID: 916153
Ref. Phy.: Ibrahem Mohamed Abo arais Study Date: 29/09/2025

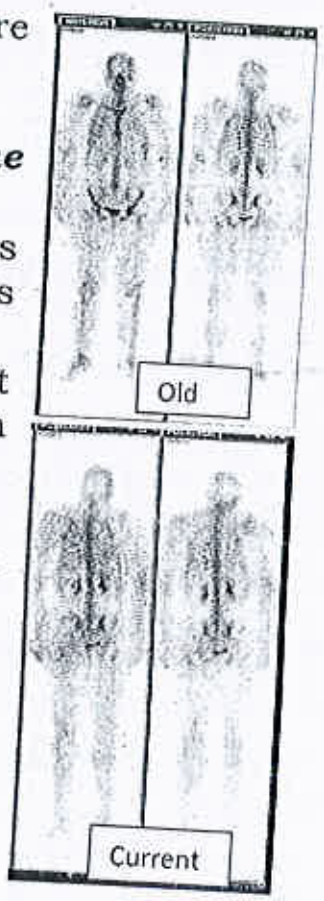
TC-99m MDP WHOLE BODY BONE SCAN

History

- 44-year-old female patient who gave history of surgically treated right breast cancer few years ago, complains of bony aches and referred for metastatic work up.

Technique

- Anterior and posterior whole-body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.



Findings

Compared to last scan dated 23-6-2025, the current scan revealed.

- Rather stationary course of old osseous lesions at the left acetabulum, bilateral ischial bones and trochanteric region of the left femur.
- Multiple active osseous lesions involving the left side of the ribs posteriorly in linear pattern likely post traumatic sequel.
- No newly developed osseous lesions detected.
- Degenerative changes are noticed at different levels of the spine.

IMPRESSION

- Rather stationary course of the previous osseous lesions at the aforementioned sites likely metastatic, for regional radiological correlation and follow up.

Much Obliged
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine

ا.د. أحمد كمال الدرى
ا.د. محمد أبو الهدى درويش
ا.د. عمر حسين عمر
ا.د. وحيد حسين طنطاوى
ا.د. ياسر عبد العظيم عباس
ا.د. أحمد محمد مليب
أساتذه الأشعة التشخيصية
كلية الطب - جامعة عين شمس

MRS. MONA AL SAYED A. MEKHEMER PATIENT ID: 916153
DEAR SIR STUDY DATE: 25/02/2026

- The portal vein is patent with no thrombosis.
- Normal CT appearance of the spleen and pancreas.
- Normal CT appearance of right suprarenal gland.
- Stable appearance of the small benign looking left adrenal adenoma, measuring 8.5mm.
- Both kidneys are functioning and normal. Stable clear bilateral renal cortical cysts, the largest is seen at the upper pole of the left kidney measuring 20mm.
- No ascites.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- Normal filling of the urinary bladder with normal wall thickness and no calculi.
- Normal C.T appearance of the uterus with no adnexal masses.
- Distended different colonic segments with fecal matter loading and sizable obstructing soft tissue lesions.
- Bone window study revealed:
  - Still noted partially healing fracture of the posterior aspect of multiple left lower ribs.
  - Stable appearance of the small sclerotic bony lesions at the left posterior acetabulum/pubic bone, LV1 vertebral body, left proximal femoral shaft and right iliac bone.
  - Old united fracture of both inferior pubic rami.



IMPRESSION:-

- **No suspicious pelviabdominal lesions.**
- **Stationary fatty liver with no focal lesion and bilateral renal cortical cysts.**
- **Stable sclerotic osseous lesions and partially healing fractures.**

MUCH OBLIGED
PROF DR. AHMED FATHY
PROF.DR. YASSER IBRAHIM

ا.د. أحمد كمال الدرى
ا.د. محمد أبو الهدى درويش
ا.د. عمر حسين عمر
ا.د. وحيد حسين طنطاوى
ا.د. ياسر عبد العظيم عباس
ا.د. أحمد محمد منيب
أساتذه الأشعة التشخيصية
كلية الطب - جامعة عين شمس

MRS. MONA AL SAYED A. MEKHEMER PATIENT ID: 916153
DEAR SIR STUDY DATE: 25/02/2026

This female patient with history of right mastectomy for breast cancer, in comparison to the previous study dated 29/9/2025, the current study revealed:

MULTISLICE C.T. SCAN OF THE CHEST

Multislice axial contiguous thin cuts were taken through the chest after I.V. **non-ionic** contrast injection.

FINDINGS:-

- Clear right mastectomy operative bed.
- No suspicious enhancing left breast lesions.
- Stable few small benign looking left axillary lymph nodes having preserved ovoid outline and fatty hilum, the largest is measuring 16mm, mostly reactionary.
- Both lungs show normal appearance of their parenchyma and pulmonary vasculature.
- No pulmonary masses, nodules or consolidation patches.
- Still noted subpleural faint reticular infiltrates are seen in the anterior segment of the right upper and middle lobes, mostly of post radiation sequel.
- Normal C.T. appearance of the mediastinal structures.
- Left sided Port-A-Cath is seen with its distal end reaching the inferior aspect of the superior vena cava.
- No significant mediastinal or hilar adenopathy.
- Patent tracheo bronchial tree.

IMPRESSION:-

- **Clear right mastectomy operative bed with no suspicious pulmonary or nodal lesions.**

MULTISLICE C.T. SCAN OF THE ABDOMEN AND PELVIS:-

Multislice post contrast CT scan of the abdomen and pelvis with multiplanar reformatted images revealed:-

FINDINGS:-

- Stationary fatty liver with no suspicious focal lesions.
- No intra or extrahepatic biliary dilatation.

Name : Mona El-Sayed Ahmed Mikhaymir	**Date : 04-10-2026 09:39**
Branch : Maadi	**Medical No. : 476001**
Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt	**Ins.Company : التامين الصحي**

Tc-99m MDP WHOLE-BODY BONE SCINTIGRAPHY REPORT

45-year-old female with right breast cancer diagnosed in 2019, post right breast surgery, chemotherapy, and radiotherapy, on hormonal therapy.

Procedure: Whole-body anterior and posterior planar bone scintigrams were acquired 3 hours after intravenous Tc-99m MDP administration.

Findings were compared with the prior study of June 25, 2026.

FINDINGS

- Mild focal radiotracer avidity is noted in the left acetabular and iliac region. Faint low-grade uptake is seen in the upper sternum, with persistent linear tracer fixation along the posterior left ribs.
- The thoracic and lumbar spine show heterogeneous distribution consistent with osteophytosis and degenerative spondyiosis, without new widespread focal osteoblastic lesions.
- Compared with the study of June 25, 2026, there is continued marked regression and further reduction in radiotracer uptake in the left acetabulum and pelvic bones, consistent with an ongoing favorable treatment response. The faint sternal focus is stable to slightly decreased, and the left rib linear activity is unchanged, consistent with stable post-traumatic sequelae rather than active metastatic progression.
- Symmetric renal uptake with physiological bladder clearance.

IMPRESSION

- Significant interval regression of radiotracer avidity in the previously documented pelvic metastases.
- Stable non-progressive low-grade findings at the upper sternum and posterior left ribs.
- No newly emerging foci of abnormal osteoblastic activity suspicious for metastatic disease.

Dr. Alaa Nagi, MD

Nuclear Medicine

NILE DIAGNOSTIC CENTER

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]